

Fecha Última Actualización: 04-03-2023 13:19:20

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Ana Dolores Esmeraldas Correa	Rut : 41.345.987-7	N° Archivo : 2224819	N° Epicrisis : 343888
Edad : 37a 3m 1d	Fecha Nacto : 03/12/1985	Sexo : Femenino	
Dirección : Pje Las Castañuelas 3796, P. Los Almendr	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 3946 7241	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Partos	Fecha Ingreso : 27/02/2023 06:03	Días Estadía : 5
Unidad de Egreso : Puerperio (2° Piso)	Fecha Egreso : 04/03/2023 13:03	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Cefalea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES
Mórbidos:Obs. HTA crónica por PA elevadas desde el 1° trimestre
Qx:(-)
Medicamentos: (-)
Alergias:(-)

Ginecoobstétricos:
FO: 10/02/00/2 PV
Ant. de preeclampsia y RCIU en embarazos previos
FUR: 12/07/22

Resumen de historia clínica:

Paciente M2PV, cursando embarazo de 32+6 semanas, consulta a urgencia maternidad el día 27/02/23 por cefalea y aparente crisis convulsiva en domicilio según refiere su acompañante. Ingresa hipertensa en rango de crisis (PA 190/124). En urgencias evoluciona con crisis convulsiva tónico-clónica que se maneja con 10 mg de diazepam. Posterior a crisis es trasladada a parto para monitorización. En parto paciente post ictal. Recibe carga de sulfato de magnesio (5g) y luego se deja mantención a 1g/h. Evoluciona con bradicardia fetal por lo que se indica cesárea de urgencia.

El 27/02/23 a las 05:55 se recibe RN de sexo femenino, viva, activa, con llanto vigoroso, Peso 1585g, talla 41 cm, pgar 8/8, quien se hospitaliza en neonatología. Se constató DPPNI del 50%, placenta se envía a biopsia diferida. En el intraparto presentó crisis hipertensivas que se yugularon con labetalol. Se intubó y se trasladó a UCI para seguimiento.

Se extubó precozmente, bien tolerado, sin embargo, persistió hipertensa, sin otras disfunciones orgánicas. En ese contexto se inició BIC de labetalol + captopril, con indicación de completar 48h de sulfato de magnesio posparto.

Se revisan exámenes de ingreso que impresionan concordantes con SHE:Hto 49,8, Hb 16,2, GB 23520, Plq 163.000, Ac urico 5,2, Alb 3,3, BiliT 1,29, BiliD 0,21, FA 219, GOT 122, GPT 52, Crea 0,69, BUN 4,8, LDH 1104, TP 12,1, INR 0,99, TTPK 26,4. Por convulsión se completa estudio con RM de cerebro que evidencia edema subcortical y yuxtacortical en secuencia FLAIR bilateral, compatible con PRESS, sin HSA ni infartos. Logró adecuado control de presiones arteriales, por lo que se suspendió BIC de labetalol y se dejó con nifedipino (20 mg cada 8h) y captopril (6.25 mg cada 8h) con buena respuesta.

Fue evaluada por equipo de neurología quienes indican manejo con levetiracetam (500 mg cada 12h) durante 1 mes, con indicación de suspender si tapering y control en CDT de neurología al alta.

Actualmente paciente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, clínicamente asintomática para

Fecha Epicrisis : 04/03/2023 13:19

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 04-03-2023 13:19:20

Página 2 de 3

SHE. No ha presentado nuevos episodios convulsivos. No refiere dolor. Se mantiene con diuresis clara espontánea y tránsito a gases, deambulando sin conflicto, tolerando régimen común.

Al examen físico hidratada, bien perfundida, mamas sanas, abdomen BDI con útero retraído infraumbilical y loquios fisiológicos escasos. Herida operatoria sana, bien afrontada, sin dehiscencias ni signos de infección. Extremidades inferiores sin edema ni signos de TVP. Dada buena evolución clínica se decide alta con seguimiento ambulatorio por equipo de neurología.

Diagnósticos de egreso:

M2 PV

Puérpera de cesárea de urgencia (5° día) por eclampsia + EFNT

- Embarazo de 32+6 semanas

- Preeclampsia severa

- Eclampsia

- DPPNI

Grupo B Rh (+)

Diagnóstico de Egreso

ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, sin dolor, con diuresis clara espontánea, tránsito a gases, deposiciones (+), deambulando sin conflicto, tolerando régimen común. Se mantuvo con HBPM para tromboprofilaxis.

Al examen físico hidratada, bien perfundida, mamas sanas, abdomen blando, depresible, sensible difuso, sin signos de irritación peritoneal, con herida operatoria sana, bien afrontada, sin dehiscencias ni signos de infección. Extremidades inferiores sin edema ni signos de TVP.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Régimen bajo en sal

Abstinencia sexual por 4 semanas

Aseo frecuente de herida operatoria sólo con agua y jabón

Toma de presión arterial 3 veces al día en domicilio luego de haber estado al menos 5 minutos en reposo. Anotar en cuaderno.

Medicamentos:

Paracetamol 500 mg: 2 comprimidos cada 8 horas por 2 días y luego SOS en caso de dolor

Nifedipino 20 mg cada 8 horas vía oral permanente

Captopril 6.25 mg cada 8 horas vía oral permanente

Levetiracetam 500 mg cada 12 horas vía oral permanente

Controles:

Retiros de puntos de herida operatoria próximo lunes 06/03/23 en consultorio. Acudir con epicrisis.

Control en policlínico de neurología al alta. Pedir hora con epicrisis en CDT Pasillo 9.

Control en consultorio en 7 días con cuaderno de presiones arteriales. Ajustar dosis y esquema según respuesta

Consultar a urgencia maternidad en caso de dolor intenso que no ceda con analgesia indicada, fiebre, sangrado genital abundante, flujo vaginal de mal olor, enrojecimiento o dolor mamario, herida operatoria enrojecida/ con secreción purulenta, molestias urinarias o en caso de estimarlo necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 04/03/2023 13:19

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 04-03-2023 13:19:20

Página 3 de 3

INTERNO

Camila Alejandra Alvarez Bustos

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 04/03/2023 13:19

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 18:00

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar